



INTERPRETACIÓN DE RAYOS X®

lunes, 15 de diciembre de 2025

NOMBRE DEL PACIENTE: CARRAZCO SUAREZ ALVARO

EMPRESA: VALIANT

TIPO DE RADIOGRAFÍA: COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL.

Desviación dextroconvexa lumbosacra con vértice en L-3 de 4 ° (ángulo de Cobb modificado), con hiperlordosis y ángulo de Ferguson 40 °

Los espacios intersomáticos con pinzamiento L5-S1

El esqueleto muestra densidad y trama ósea normales. Sin observarse fracturas, otros colapsos ni neoplasias. Los cuerpos, láminas, apófisis y pedículos se aprecian normales.

Lo visible del abdomen y la pelvis dentro de límites normales. Desnivel pélvico derecho de 2.0 cm.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

- DESVIACIÓN DEXTROCONVEXA LUMBOSACRA (4 °) CON HIPERLORDOSIS Y CON ANGULO 40 °.
- PINZAMIENTO L5-S1
- NO SE IDENTIFICAN FRACTURAS NI TUMORACIONES.
- BASCULACION PELVICA DERECHA DE 2.0 cm.

Dr. José Antonio Gómez Jardon

Medico Especialista en Radiología e Imagen.

Ced. Prof. Esp. AECEM-23687.





SOLUCIONES
MÉDICO
EMPRESARIALES®

INTERPRETACIÓN DE RAYOS X®

lunes, 15 de diciembre de 2025

NOMBRE DEL PACIENTE: CARRAZCO SUAREZ ALVARO

EMPRESA: VALIANT

TIPO DE RADIOGRAFÍA: TELE DE TORAX PA

Tórax con tejidos blandos normales. La tráquea de calibre y trayecto normal. El diafragma con altura normal y ángulos costo y cardiofrénicos libres. Pleura sin patología aparente. No se identifican derrames ni paquipleuritis.

Pulmones bien ventilados, con trama normal, sin evidencia de infiltrados ni consolidaciones. .

El esqueleto con densidad y trama ósea normal, sin lesiones traumáticas o neoplásicas. .

La silueta cardiovascular con perfiles bien definidos, con morfología y situación normal. El índice cardiorádico normal, sin cardiomegalia radiológica.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

- TORAX RADIOLÓGICAMENTE NORMAL, SIN PATOLOGÍA AGUDA PLEUROPULMONAR APARENTE.

Dr. José Antonio Gómez Jardon

Medico Especialista en Radiología e Imagen.

Ced. Prof. Esp. AECEM-23687.

